

03 - 03- TORSION DU CORDON SPERMATIQUE - Pr. KAMILI

(0:11 - 0:29)

Alors aujourd'hui nous allons voir un autre chapitre de la chirurgie pédiatrique viscérale. C'est un chapitre qui touche le volet des urgences, voire même les extrêmes urgences. Donc on va parler de la tension du cordon spermatique.

(0:32 - 0:45)

Testicule perdu avec trois tours de spire que vous voyez. Donc ça c'était juste pour un avant-goût de ce chapitre. Alors pour voir ce chapitre nous allons suivre le plan suivant.

(0:46 - 1:35)

Donc après l'introduction nous allons voir un rappel anatomique de la physiopathe avant de passer au diagnostic positif qui est l'objet principal de ce cours. Parler du diagnostic différentiel, du traitement, du pronostic avant de conclure. Alors en introduction nous allons dire que la tension du cordon spermatique c'est la strangulation des testicules autour de son pédicule spermatique, d'accord? Il s'agit là d'une urgence extrême qui se compte en heures, d'accord? Parce qu'il y va de la vitalité testiculaire vu le risque encouru de nécrose testiculaire.

(1:36 - 1:49)

La certitude diagnostique est opératoire. Donc je tiens à le redire, la certitude diagnostique est opératoire. Nous allons voir la corrélation de cette phrase tout au long de ce chapitre.

(1:50 - 2:37)

Donc la tension du cordon spermatique peut survenir à tout âge. Mais il y a, comme nous l'avons dit l'autre fois, il y a deux pics de fréquence. Il va y avoir la période néonatale et l'approche de la puberté, d'accord? Alors, pour le rappel atomique, vous connaissez la gonade masculine, à savoir le testicule qui est enveloppé de, il y a l'albugéné et puis il y a là l'enveloppe vaginale, d'accord? Et après la vaginale, il y a les cinq autres enveloppes parce que le testicule il a combien d'enveloppes? Sept enveloppes, d'accord? Bien, nous allons voir la suite de ce rappel.

(2:37 - 17:45)

Donc le testicule avec le muscle crémasterique, le crémaster et puis il y a le cordon spermatique, constitué d'un réseau veineux qui entoure le flux artériel et puis il y a le canal déférant qui est le rapport interne du pédicule spermatique, d'accord? Il y a une part de la vascularisation finiculaire, c'est-à-dire différentielle qui participe à la vascularisation des testicules, ok? Bien, toujours ce rappel de la vascularisation parce que c'est la hontise en matière de tension spermatique c'est l'arrêt du flux vasculaire qui va entraîner la nécrose testiculaire.

Bien, coupe anatomique normale, donc le déferrant avec le vestige du processus vaginalis c'est-à-dire du canal péritoneal vaginal, c'est-à-dire le ligament de cloquet, d'accord? Bien, et là il y a des vestiges embryonnaires, il y en a épididymaires et le plus fréquent c'est l'idatite de morganie parce qu'une petite torsion de cette idatite peut simuler une torsion du cordon spermatique, d'accord? Il y a l'idatite testiculaire, mais la plus fréquente c'est l'idatite de morganie qui est épididymaire, d'accord? Bien, et puis il y a le ligament scrotal, ici Sur le plan physiopathologique, donc nous allons parler du pourquoi et le comment de la torsion des testicules Donc pour cela nous allons revoir les moyens de fixité des testicules Donc l'axe, il y a tout d'abord l'axe cordon testicule-ligament scrotal Cet axe, d'accord, c'est l'un des éléments de fixation, ok? Puis il y a la situation extravaginale de la majeure partie de l'épididyme qui est ainsi accolée aux enveloppes scrotales L'épididyme, la partie extravaginale est accolée aux enveloppes scrotales, ici, d'accord? Bien, alors pourquoi attendre? Cela c'est la fixation qui est normale Dans la figure P, il y a l'absence de ligament scrotal, il manque ici, le ligament scrotal Et on a un mésorchium, le mésorchium c'est cela, il est incomplet Regardez par rapport à la normale, l'étendue du mésorchium, ici elle est incomplète, d'accord? Ici il y a l'absence de mésorchium et de ligament scrotal avec deux cul-de-sac vaginal autour du cordon, d'accord? Donc pas de mésorchium, pas de ligament scrotal et puis les cul-de-sac, il est autour du cordon spermatique, d'accord? Ici il y a une déconnexion épididymotesticulaire, d'accord? Donc ici, ici et là, il y a tout autant d'anomalies qui vont favoriser la torsion du cordon spermatique, d'accord? Ou bien la torsion du testicule Alors cette distinction entre l'extra ou supravaginale et l'intravaginale, elle est capitale Parce qu'elle va conditionner le travail chirurgical, nous allons voir ça plus tard Bien, voici l'image correspondante, vous voyez que la torsion est supravaginale Voici la vaginale en rouge et la torsion est supravaginale, il y a deux tours de sphère ici, d'accord? Bien, la torsion intravaginale, c'est la plus fréquente, elle peut se voir à tout âge, surtout chez le grand enfant ou l'adolescent Elle intéresse le cordon au pôle supérieur du testicule, d'accord? Mais toujours dans la vaginale, à l'intérieur de la vaginale Il est favorisé par des anomalies d'insertion de la vaginale fixées très haut sur le cordon Le testicule peut alors pivoter sur son axe à l'intérieur de la vaginale C'est bon? Bien Alors qu'elle soit supra ou intravaginale, la torsion des pellicules spermatiques entraîne d'abord l'interruption du retour veineux Puis une interruption du flux artériel aboutissant à la nécrose et à l'infarctissement du testicule Ces lésions deviennent en quelques heures irréversibles avec perte de la spermatogénèse dès la sixième heure Et la nécrose des cellules de l'épididyme dès la dixième heure C'est dire encore une fois l'extrême urgence à laquelle il faut faire face pour pouvoir sauver ce testicule Nous arrivons maintenant à la clé de ce chapitre, à savoir le diagnostic positif On va choisir comme type de description la torsion des cordons spermatiques chez le grand enfant avec testicule en place Donc à l'interrogatoire, douleur, c'est une douleur brutale, scrotal, avec irradiation inguinale Il faut préciser l'heure des débuts parce qu'il y a une corrélation médico-légale Et pour voir à quelle étape vous recevez l'enfant, est-ce qu'il va falloir espérer sauver le testicule ou pas Souvent on trouve des antécédents de crise douloureuse spontanément résolutive Cela veut dire qu'il s'est produit une torsion qui s'est détendue spontanément La douleur finit par s'atténuer au bout de quelques heures Ce sont les éléments à

rechercher à l'interrogatoire Et puis, l'examen clinique, le plus souvent il se limite à l'inspection Pourquoi? Parce que la grosse bourse est tellement inflammatoire et très douloureuse qu'on ne peut même pas examiner l'enfant par la palpation Même la palpation ne serait pas concluante parce que c'est un magma, un gros magma C'est rare qu'on ait l'occasion de pouvoir faire la palpation et dans ce cas nous allons voir ce qu'on va trouver Alors, à l'inspection, il s'agit d'une bourse augmentée de volume et légèrement inflammatoire Le testicule est tuméfié, extrêmement douloureux et rétracté à l'anneau C'est ce qu'on appelle le signe de gouverneur Il est toujours surélevé par rapport à l'autre testicule contrôlataire D'accord? En le soulevant, c'est à dire lorsqu'on soulève ce testicule On va augmenter la douleur alors qu'on la soulage en cas d'épidémie C'est ce qu'on appelle le signe de prene Alors, en cas de tension, le signe de prene est négatif Et en cas d'épidémie, le signe de prene est positif D'accord? Alors la transillumination est négative, bien que parfois on a une petite hydroselle réactionnelle à toute cette inflammation Mais en général, la transillumination est négative Le cordon est douloureux et enduré Et puis on n'a plus de réflexe crématérien D'accord? Le réflexe crématérien est aboli Voilà, une grosse bourse inflammatoire droite chez un petit garçon Examen complémentaire, donc aucun examen à demander Retenez ça, il risque juste de retarder le geste salvateur D'accord? Ok? Après avoir vu cette forme de description, nous allons maintenant voir les formes cliniques Et on va commencer par les formes néonatales C'est une torsion nuandale souvent de survenue anténatale Donc in hétéro La torsion est supravaginale La bourse est inflammatoire et peu ou pas douloureuse Les lésions le plus souvent sont irréversibles Donc le plus souvent ça se solve par une orchidectomie Parce que ça a dépassé les délais D'accord? Et c'est très malheureux à la naissance Voilà Testicule couleur aubergine Donc nécrosée avec des lésions d'infarctissement et de nécrose Ok? Maintenant, nous passons à la torsion sur testicule ectopique Des diagnostics difficiles Lorsqu'elle est en position abdominale, la douleur serait abdominal D'accord? Sinon, il serait inguinal, la douleur serait du siège inguinal D'accord? La bourse est vide On a une masse inguinale douloureuse Diagnostic clinique ou échographique Surtout la clinique, c'est un réflexe Vous avez une tumefaction inflammatoire au niveau de l'aîne Avec une bourse vide Le premier diagnostic à évoquer c'est une torsion sur testicule ectopique Bien sûr il y a la hernie inguinale étranglée Mais lorsque la bourse est vide, attention Le premier diagnostic c'est torsion sur testicule ectopique D'accord? Le traitement est chirurgical, c'est la détorsion et l'orchidopexie C'est le cas heureux D'accord? Bien Comme diagnostic différentiel Nous allons dire que pour l'invagination intestinale aiguë Éliminez d'abord, s'il vous plaît Éliminez d'abord la torsion D'accord? Et pensez à d'autres Parce qu'il y en a d'autres Il y a la torsion d'annexe testiculaire C'est quoi? Ce sont des reliquats des canaux de Wolff et de Muller Il s'agit le plus souvent d'idatides Les ipididymères sont les plus fréquentes Dont le plus fréquent c'est l'idatide de Morganie Vous voyez ici Je ne sais pas si l'idatide de Morganie est tordue D'accord? Et puis il y a les idatides testiculaires Sur le plan clinique, il y a une douleur scrotal De début brutal, modérée Comparativement à celle de la torsion du corps dans le spermatique C'est une douleur localisée Le testicule n'est pas rétracté Et on peut palper parfois un nodule au niveau du pôle supérieur du testicule D'accord? Le traitement Bon, c'est certitude, diagnostic, repos au lit,

ontalgique, anti-inflammatoire Mais rappelez-vous Je vais le dire encore une fois La certitude n'est qu'opératoire Torsion d'idatide D'accord? Vue par opératoire Deuxième diagnostic différentiel Lorsqu'il y a des limites aiguës Fièvre Le plus souvent, le primo moment 20, c'est une infection urinaire D'accord? Le début est moins brutal, donc il est positif Pardon, il est progressif Le début est progressif Le testicule est au fond de la bourse Donc il n'est pas surélevé Le signe de prene est positif ici D'accord? Et bien sûr, il va falloir Après avoir éliminé une torsion Il va falloir procéder à faire un ECBU Pour éliminer l'infection urinaire Et la traiter Autre cause de grosse bourse aiguë Il y a le traumatisme scrotal Et bien sûr, lorsqu'on a une hernie inguinale crotale Qui est étranglée Parce qu'on a une grosse bourse également D'accord? Mais tout scrotum aiguë Impose une exploration chirurgicale Dans la crainte d'une torsion du cordon spermatique Ça c'est le message à prendre de secours Le traitement Donc exploration chirurgicale en extrême urgence avant la sixième heure Ne demandez pas d'examen paraclinique s'il vous plaît D'accord? Abort inguinal pour la torsion supravaginale Donc on fait un abort inguinal Chez le nouveau-né et le petit nourrisson Parce que la torsion est supravaginale Vous la trouverez mieux en abordant par voie inguinale Par contre, chez les grands Qui ont une torsion intravaginale L'abord est scrotal On ouvre le scrotum, on ouvre la vaginale Et on détend les tours de spire Si le testicule est nécrosé On procède à une castration C'est-à-dire à une orchidectomie Si le testicule est viable Il sera conservé Et dans tous les cas On procède à la fixation des testicules contralatérales D'accord? Là c'est un testicule tordu Avec un tour de spire Mais l'aspect est prometteur Donc le plus souvent ça se recolorise Après la détorsion d'un seul tour de spire Surtout lorsqu'il n'est pas serré D'accord? Là vous avez Un abord scrotal On l'a ouvert du côté droit Parce qu'il est le siège de la torsion Vous voyez la couleur aubergine Ça va sûrement se solder par une orchidectomie On a fait sortir l'autre Pour procéder à l'orchidopexie C'est-à-dire à la fixation Pour ne pas avoir le même problème De l'autre côté Ultérieurement D'accord? Bien Donc toujours Nécrose testiculaire Nécrose testiculaire C'est malheureux Donc en conclusion Qu'est-ce qu'il faut? Tous crotomes aigus Imposent l'exploration chirurgicale en urgence Parce qu'il vaut mieux Une exploration blanche Qu'un testicule noir